

Paciente	Cecília Maria Albergaria Silva	Atendimento	1.300.781
Nome Social		Convênio	Casu / Enfermaria
Data Nascto	30/06/2020 2 meses	Registro	29/09/2020 12:51:57
Data Entrada	04/08/2020 11:40:09	Prontuário	301.935
Setor/Leito	2º Andar - Cti Infantil - CTI 12		
Médico Resp	Silvania Ferreira Kohnert		

Data de admissão: 04/08/2020 **Data da alta:** 29/09/2020
Procedência: Pronto atendimento do Hospital Belo Horizonte
Destino: Pediatria do Hospital Belo Horizonte

À alta: Dias de internação: 57 dias
Peso: 3882g **Perímetro cefálico:** 37,5 cm. **Comprimento:** 51cm

HISTÓRIA:

Lactente admitida com 1 mês e 5 dias, apresentando crise convulsiva tônico clônica, com duração superior a 15 minutos, associada a hipotermia. Até aquele momento, em aleitamento exclusivo, com adequado ganho ponderal. A família cumpria o isolamento social.

No pronto atendimento, verificado abaulamento de fontanela, feito dois bolus de midazolam, colocado em oxigênio, glicemia capilar: 166 mg/dl. Recebeu uma dose de ceftriaxona e coletado rastreio infeccioso, ions e gasometria. Mãe nega herpes na gestação e após.

Encaminhada para monitorização acompanhada de médico.

EVOLUÇÃO EM CTI

NEUROLÓGICO:

Admitido com quadro neurológico agudo (convulsão e abaulamento de fontanela).

Ultrassonografia transfontanelar (04/08): hemorragia intraventricular grau II-III bilateral.

Tomografia de encéfalo (04/08): extensa hemorragia em caudado à direita com inundação ventricular e hidrocefalia.

Implantada derrivação ventricular externa (DVE), em 04/08.

Angiotomografia arterial e venosa intracraniana (11/08): Sem má formação arterio venosa (laudo em anexo).

A crinaça não tolerou a retirada da derivação ventricular, sendo submetida à implantação de derivação ventrículo peritoneal, em 08/09/20.

Ressonância de encéfalo (16/08): hidrocefalia, resquícios de sangramento e áreas de malácea em região periventricular posterior bilateral, frontal esquerda.

Controladas crises convulsivas com fenobarbital. A criança apresenta melhora progressiva do quadro neurológico, sendo a reduzida aceitação oral a alteração mais importante.

RESPIRATÓRIO

Entubada, à admissão, em função do quadro neurológico (irritabilidade e hipertonia). Como medida de proteção cerebral, foi mantida em ventilação, com parâmetros baixos, até o dia 12/08. Manteve bom padrão respiratório, ar ambiente, sendo reintubada, eletivamente, para procedimento neurocirurgico.

CARDIOVASCULAR/HEMATOLÓGICO:

Admitida com hemoglobina de 5,6, apresnetando instabilidade hemodinâmica. Recebeu hemotransfusão e necessitou de adrenalina, em dose baixa, por 24h.

Para investigação da causa da hemorragia cerebral, foi solicitada avaliação da hematologia que indicou dosagem do fator XIII. O resultado sofre alteração pelo uso do DDVP e foi repetida coleta, em 28/09 (em andamento).

Apresenta, atualmente, anemia multifatorial, sem repercussão hemodinâmica e está sendo mantida reposição enteral de ferro.

INFECCIOSO: Iniciados à admissão, ceftriaxona, ampicilina e aciclovir. Com diagnóstico de sangramento cerebral, os antibióticos foram suspensos em 05/08.

Em 10/08, iniciou com febre. Iniciado tratamento para infecção urinária, mas pela possibilidade de infecção em sistema nervoso central, a amicacina foi substituída por cefotaxima.

Urocultura(14/08/20) : *Citrobacter. freundii*.

Pela persistente alteração líquórica, optado por estender tratamento para ventriculite. Foi obsevada melhora gradual do exame, mas as culturas não mostraram crescimento.

Completo 21 dias de vancomicina e cefepime.

NUTRICIONAL:

Iniciada dieta no 2º dia de internação. Apresentou vômitos repetidos, atribuídos ao quadro neurológico. Necessitou de bomba de infusão, em sonda entérica.

Em 10/09, iniciada a oferta de aleitamento materno e obseravda piora do padrão de sucção, com exacerbado reflexo

Paciente **Cecilia Maria Albergaria Silva**
Nome Social
Data Nascto **30/06/2020 2 meses**
Data Entrada **04/08/2020 11:40:09**
Setor/Leito **2º Andar - Cti Infantil - CTI 12**
Médico Resp **Silvania Ferreira Kohnert**

Atendimento **1.300.781**
Convênio **Casu / Enfermaria**
Registro **29/09/2020 12:51:57**
Prontuário **301.935**

de vômito. Foi mantido acompanhamento com a fonoaudiologia. O padrão de sucção é irregular, em termos de aceitação, mas sem evidências de disfagia. A sucção é melhor ao seio materno. Com a observação de choro, durante em alguns horários de sucção, em 10/09, foi iniciado omeprazol. Pela curva estacionada de peso, a sonda gástrica foi mantida até a manhã de hoje, com a programação de transferência para pediatria com a mãe, para aleitamento.

Peso de admissão: 3200g. Peso de alta: 3882g

METABOLICO:

Evoluiu com *Diabetes Insipidus*, recebeu DDAVP de 05/08 até 18/09.

Por cursar também com hiponatremia, foi feita investigação de eixo hipofisário, que não mostrou alterações (exames em anexo).

ACESSO VENOSO: Epicutâneo membro superior direito: 33 dias
Epicutâneo cefálico esquerdo : 12dias

ÚLTIMOS EXAMES:

13/09/20	Hb: 8,8	HT: 28	Hm: 3,17	Plaq:290.000	
	Gl: 5200	B: 0 S: 16 M:6	E: 3 L: 73		
28/09/20	Na: 133	K: 4,6	Cl: 103		
Fator XIII: em andamento.					

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS

Hemorragia intraventricular espontânea (sem etiologia definida - AngioTC sem mal formação arterio-venosa)

Anemia aguda (hemotransfusão)

Crise convulsiva controlada

Distúrbio de sódio - *Diabetes insipidus* e *Síndrome perdedora de sal transitórios*

Refluxo gastro-esofágico presumido

Resultado de dosagem de fator XIII 152% (VR 70-140%)

Ventriculite tratada- diagnóstico por alteração líquórica - culturas negativas.

PRESCRIÇÃO ATUAL: (em anexo)

PROPOSTAS:

Acompanhar aceitação da dieta e curva ponderal.

Acompanhamento ambulatorial de: neurologia pediátrica, endocrinologia pediátrica e neurocirurgia.

Acompanhamento com fisioterapia

Acompanhamento com fonoaudiologia

Cobrar, no laboratório, dosagem de Fator XIII (após o resultado, avaliação da hematologia)

Marlice Hallak Martins da Costa
CRM-MG: 25931





Hospital Belo Horizonte - Termos e Relatórios

Paciente	Cecilia Maria Albergaria Silva	Atendimento	1300781
Nome Social		Convênio	Casu Enfermaria/
Data Nascto	30/06/2020 2m 30d	Dt. Relatório	29/09/2020 15:23:13
Data Entrada	04/08/2020 11:40:09	Prontuário	301935
Setor/Leito	Enfermaria	Profissional	Marlice Hallak Martins da Costa
Médico Resp	Silvania Ferreira Kohnert		

03/09/2020:

TIREOTROPINA (TSH) NEONATAL: 2,36 mcU/mL em sangue

Material: Sangue Papel Filtro

Método...: Imunofluorimétrico

TIROXINA (T4) NEONATAL RESULTADO: 7,9 mcg/dL equivalente em soro

Material: Sangue Papel Filtro

Método...: Imunofluorimétrico

19/09/20

DENSIDADE URINÁRIA: 1.015

Material: Urina Aleatória

Método...: Análise Química em Fita

SÓDIO NA URINA: 86,0 mEq/L

Material: Urina

Método...: ISE

18/09/20

ACTH - HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO: 22 pg/mL

Material: Sangue

Método...: Quimioluminescência - DPC

Valor de Referência: Até 46 pg/mL

CORTISOL

Material: Sangue

Horário da Coleta: 09:34H

RESULTADO: 10,6 mcg/dL

Transcrição dos exames.